

益安

(6499 TT, NT\$68.5, 增加持股)

重點摘要

1. Urocross 於 3M26 取得美國 FDA 510(k)上市許可，正式商業化仍需進行產線與供應鏈優化等準備工作。目前於國際授權談判進展正面，部分大廠已進入決定性條款的深入討論階段。臨床數據方面，美國 Expander-2 試驗於 30 個月時 IPSS 指數改善幅度達-51.3%，顯著優於市場同業表現，且臨床嚴重不良反應紀錄為 0。
2. Duett 在臨床試驗中維持零滲血的優異表現，目前合作收案醫院已從原先的 4-5 家成功翻倍增長至 10 家醫院，已完成總收案量 72 例的 60%。Cross-seal 方面，面對 Terumo 終止專案之合約爭議，雙方經談判已達成合理和解共識，預計近期法律程序定案後，將為公司注入一筆可觀的結算現金流。
3. CDMO 業務，公司聚焦高門檻的介入性微創醫材代工，提供自研自製一站式服務，2Q26 營收相較 1Q23 大幅成長 3 倍。在客戶營收結構中，占比有 67%處於利潤極佳的臨床試量產階段；且專案前期的設計開發與驗證成本 100%由客戶全額支付。

結論

益安生醫 1H26 對比 1H24 營業損失已大幅收斂 38%且研發費用減半，財務結構顯著改善。短期內，公司除了在協商 Terumo 計畫移轉與中止後的賠償金額 1,900 萬美元外，更聚焦於 Urocross 取得 FDA 上市許可後的商業化準備以及其已進入實質決定性條款的國際授權談判；同時，Duett 主動脈修復醫材其醫院收案增加，已完成總收案量 60%；最終，公司 CDMO 業務將貢獻穩定現金流支柱，以雙軌策略穩健支撐營運，加速實現轉虧為盈。

2026 年營運重點

- 四大核心專案
 - 創新產品研發（三大專案）：Urocross、Duett（胸主動脈修復）、Cross-seal（與 Terumo 合約案）；其商業模式為開發授權，旨在為公司爭取高額且具爆發性的資本利得回收
 - 穩定現金流（一個專案）：CDMO，專注於高技術門檻且利潤較佳的微創/低侵入性代工業務；旨在為公司提供穩定的現金流

Urocross (攝護腺微創醫材)

- 背景
 - 攝護腺肥大（BPH）是中高齡男性極普遍的疾病
 - 50 歲以上男性約有 50%面臨此症狀困擾，而 80 歲以上男性更是高達 80%

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 尋求治療病患分布與藥物局限
 - 光是美國就有高達 4,000 萬名患者有相關症狀，但其中真正主動尋求治療的僅有 1,400 萬人
 - 尋求治療的病患中，約有 55% 的人接受藥物治療，使用高血壓類藥物以讓攝護腺肌肉放鬆，是最簡單的方式
 - 藥物治療伴隨較大的副作用，因此大多數患者在服藥 1 至 2 年後，便被迫停止用藥
 - 另外約有 35% 尋求治療的患者，僅靠調整生活習慣（如不喝過多水、忍耐頻尿）進行觀察與等待
- 手術抉擇的掙扎與性功能顧慮
 - 一旦病患因副作用停藥，下一步就必須面臨是否接受手術治療的痛苦掙扎
 - 手術分為高侵入性與低侵入性：傳統手術（如開刀、割除）侵入性高、效果徹底，但副作用也極大，需插尿管約一週，並伴隨流血與疼痛
 - 男性患者最擔憂的傳統手術副作用，是可能在手術中不小心傷到並永久損害性功能
 - 低侵入性微創產品因其幾乎不影響性功能的優點（機率接近零），在市場上極受病患歡迎
- 治療空窗期的商機
 - 大多數病患因為恐懼高侵入性傳統手術對性功能損害的副作用，在停藥後選擇強忍症狀，停滯在藥物治療與觀察等待之間
 - Urocross 的出現正好完美填補了這一治療空窗期，蘊含龐大商機
- 傳統醫材演進與 30-40 年前支架災難
 - BPH 治療在過去 100 年中不斷演進
 - 最少侵入性的是藥物（約 60-70 年前開始），再來是用高溫燒灼或割除（如雷射、水蒸氣等）
 - 30 至 40 年前，業界曾嘗試將金屬支架放進尿道，初期數月效果不錯，但隨後全面復發並引發嚴重併發症
 - 化學結石環境：血管支架放進去後會被血管壁包覆固定；但尿道經常接觸尿液，酸鹼度與化學成分極易導致支架產生嚴重的尿道結石；最終導致支架與結石卡死在尿道中，取出過程比雷射燒灼更困難，往往需要進行高難度的大手術
- 同業產品缺陷與 Urocross 「可取出」設計
 - 同業在實際使用或臨床試驗中，由於病人不適或結石風險，實際上仍有極高比例需要將支架取出
 - 益安是唯一一家專門針對「安全且容易取出」進行專利設計的醫材廠：設計不走永久植入死路；放進去 6 個月後便能以簡單勾出的方式主動取出，完全保留病患後續的治療彈性；Urocross 拿掉後體內無任何金屬殘留，完全保留未來治療與檢測的彈性
 - 若體內留有永久性金屬支架，病患未來若面臨膀胱、攝護腺病變或癌症，將無法進行 MRI 核磁共振
 - 在 Urocross 的所有臨床試驗中，嚴重不良反應（SAE，Severe Adverse Effect）通報紀錄為 0，安全性極佳

- 對手產品的 FDA 臨床試驗協定註冊為永久植入，若在試驗中途因副作用被迫取出，在統計上會直接被判定為臨床試驗失敗
- 益安 Urocross 的臨床協定明確規劃為暫時性置入，完全符合合規流程，不計為失敗
- 產品具組織重塑（Remodel）機制與長期持久療效
 - Urocross 的作用原理是將支架在尿道放 6 個月後取出，尿道組織已被壞死並定型重塑（Remodel），故不會彈回
 - 人體數據證實，最長追蹤達 42 個月，症狀改善效果依然持續，病患均未復發，展現極高療效持久度
- 臨床試驗數據
 - Expander-1 試驗（安全性與黃金置放期確立）：於台灣、澳洲及加拿大進行，總計收案 45 人；測試置入 1 個月（組織易彈回）、6 個月與 12 個月（同樣有效但增加患者不便，無必要）；最終 6 個月效果最為顯著且安全，確立了黃金 6 個月置入期的產品定位
 - Expander-2 試驗設計：在美國進行的 Pivotal 臨床試驗，總計收案 240 人，採 2:1 比例分組（治療組 160 人，對照組 80 人）；對照組病患同樣送進手術室、矇上眼睛，並接受膀胱鏡模擬手術（推進推出），以確保雙盲真實；試驗解盲後，對照組中有高達 80%（約 65 人）的患者因無實際治療效果，強烈要求並改為接受 Urocross 實際治療
 - Expander-1 的 IPSS 變化軌跡：IPSS 指數越高代表症狀越嚴重。置入 Urocross 後症狀迅速緩解（IPSS 指數 6 個月下降 40% 左右）；在 6 個月取出後，療效仍持續累積下降。追蹤至 42 個月時，IPSS 指數改善幅度達到-44.3%
 - Expander-2 的優異數據與背後機制：Expander-2 追蹤至 30 個月時，43 例隨訪病患的 IPSS 指數改善幅度高達-51.3%
- 與其他公司產品比較
 - 傳統開刀手術（如割除、燒灼）IPSS 下降約 60%-63%，療效極佳，但伴隨出血、插尿管、疼痛與損害性功能等高風險副作用
 - 一般他牌永久性微創支架：IPSS 下降僅約 38% 至 43%
 - 益安 Urocross：在完全不損害性功能、零嚴重不良反應的前提下，能達到-49%至-51.3%的顯著療效
- 3M26 Urocross 取得 510(K)上市許可
 - 公司取得認證，但產品尚未上市的原因：比公司更早拿到認證的競爭對手也處於相同的準備期；通常新醫材在取得 FDA 510(k)上市許可到實際商業化，都需要一年左右的時間；醫療器材一旦上市，若發生產能不足、材料短缺導致斷貨，對品牌聲譽是毀滅性的打擊；過去 6 個月，益安均全力投入產線優化、自動化導入，以降低生產成本並確保供應鏈穩定
 - 二供機制防範斷貨風險：為防止單一材料供應商出事或斷貨，必須積極開發並認證第二供應商；這類製程與材料的微調都需要向 FDA 報備，是醫療器材產業的常態運作
 - 一整年的系統性工程：包括行銷通路布局、美國保險給付談判、各家醫院的進藥程序以及醫師的操作培訓

■ 國際授權談判的必然性與最新進度

- 小型醫材研發公司無力獨自供養數百人的銷售團隊，因此大廠合作與授權是必然道路
- 授權談判對象不只一家，部分大廠已進入實質且具決定性條款的討論階段，公司對授權前景極具信心

Duett (胸主動脈修復醫材)

■ 胸主動脈剝離與組織破裂致死率極高，黃金救治時間極短

- 傳統開胸手術需要截斷主動脈，並高度依賴體外循環將患者體溫降至 24°C
- 若體外低溫循環時間過長，病患重新復溫接回血管時，發生腦部病變的機率極高，因此手術時間分秒必爭

■ 360 度手工縫合痛點與 Duett 核心發明

- 手工縫合痛點：胸主動脈主要供應腦部與上肢的三條重要血管；開胸時手術視野受限，醫生必須進行極度困難的 360 度手工縫線，耗時極長且難度極高
- Duett 可使血管馬上連接起來，省去耗時的手工 360 度縫合，顯著縮短體外低溫循環時間

■ 吻合處零滲血

- 傳統上手工縫合血管後，醫師通常因擔心針眼滲血而不敢立即關胸，必須在現場密切觀察一段時間
- 在所有已完成的人體臨床案例中，使用 Duett 醫材的患者其血管吻合處滲血率為 0

■ 2023 年 FDA 直接核准產品 Pivotal 試驗

- 公司憑藉扎實的動物實驗與長期追蹤數據，於 2023 年獲准直接進入 Pivotal 人體臨床試驗，目標收案 72 例
- 因開心手術風險極高，FDA 第一階段限制僅能在少數幾家醫院進行前 20 例手術以確認安全
- 在順利完成並提交前 20 例安全數據後，FDA 已正式核准繼續擴大收案，顯示產品具備極高安全性

■ 合作收案醫院已從原先的 4-5 家成功翻倍增長至 10 家醫院，目前已完成總收案量 72 例的 60%（約 43 例），收案速度顯著加快

Cross-seal (大口徑心導管止血裝置)

■ 原合約總價\$50mn（\$20mn Upfront + \$30mn 里程碑金），目前已累計認列營收\$31mn

- 剩下\$19mn 里程碑金由 Terumo 負責，涉及後續次世代產品開發、量產製程改善

■ 與 Terumo 爭議

- COVID-19 期間，Cross-seal 後續任務轉由日商大廠 Terumo 負責
- 去年 Terumo 因內部戰略與資源配置轉變，通知益安將不再繼續執行此專案，欠公司\$19mn

- 雙方自 4Q25 起，針對剩餘的\$19mn 里程金合約調整展開長達數月的談判
- 最新進展：雙方目前已幾乎達成協議，確定不需要訴諸法院，將以合理且務實的方式解決此爭議
- 無法拿足\$19mn 里程金，但預期將為益安帶來一筆可觀的現金流入

CDMO 業務

- CDMO 業務自推行三年多以來成長極為強勁，相較於 1Q23 營收，2Q26 已大幅增長 3 倍
- 與一般的傳統代工廠不同，益安聚焦於技術壁壘極高的介入性高毛利微創醫療器材代工
- 自研自製一站式服務
 - 許多同業多靠外購組件進行簡單組裝，面臨極高供應鏈風險且利潤低
 - 而公司從最上游的管材製造、機構設計、電控設計到高精密組裝皆 100% 掌握，徹底掌控製程安全與利潤
- 在代工產品結構中，占比最高的是心血管介入（約佔 61%），其餘則為高技術難度的電生理介入、腦血管與神經介入產品等
- 益安的 CDMO 客戶群涵蓋了各個生命週期的產品，包括前期工程開發、臨床試量產以及商業化穩定生產
 - 營收占比中，高達 67% 處於臨床試驗/試量產階段，19% 處於商業化量產導入階段
- 美台跨國雙基地運作
 - 益安 CDMO 的主要客戶 90% 在美國
 - 在美國拿到訂單後，實際上是由台灣領先全球的工程師研發團隊主導高難度設計與技術開發，並在台灣進行量產

1H26 集團財務表現

- 隨著 CDMO 營收高速增長與各專案推進，公司整體營業損失呈現顯著且持續的縮減。對比 1H24，虧損大幅收斂達 38%
- 研發費用對比 1H24 大幅下降 49% (YoY)
 - 過去研發費用的主要大頭在於昂貴的臨床試驗收案，目前主要專案（如 Urocross）的臨床收案均已結束
 - 僅剩下少數現有隨訪病患需持續進行追蹤，因此臨床隨訪費用大幅降低，未來研發支出將維持在極低水平

QA

- 關於 Urocross 醫師技術培訓計畫之具體規劃，以及預計培訓多少位醫師？
 - 公司提供人體器官模型，讓醫生在體外進行操作模擬與手感熟練度訓練

- 首波訓練主要針對先前參與臨床試驗的醫師。接著由這些醫師作為種子，訓練其所屬醫院內部的其他醫生
- 針對近期 BPH 市場的變局（如競爭對手 Urolift 的訴訟事件），對整體市場將帶來哪些影響？
 - BPH 患者數量隨高齡化社會每年快速成長，絕對值上升，整體市場需求持續擴增，完全不因單一事件減緩
 - 雖然早期部分微創產品因誇大不實行銷或操作不當而面臨訴訟與動態調整，但整體市場往低侵入性方向發展的趨勢不可逆
- 患者於 5 年後若症狀復發，公司是否有規劃二次治療的臨床指引或相關試驗？
 - 無需重做臨床試驗，若病人在 5 年後復發，是否可二次置入 Urocross，此部分完全屬於醫生的臨床判斷
 - 無需再向 FDA 申請或重做二次治療臨床試驗來證明其有效性
- Urocross 與 Cross-seal 的授權模式是否有差異？一般重症手術醫材與 Urocross 這種微創型醫材，其授權價值與估值模式有何不同？
 - 醫材授權價值主要由兩個核心維度決定(就像蓋房子)：蓋在哪裡（地段）：即產品切入的市場規模與患者基數；蓋的成本（技術壁壘與臨床效益）：即產品本身研發製造成本
 - 業界主要參考同類產品的歷史交易價格：市場同類 Urolift，其平均單次耗材成本約為 6,000 美元，而醫院端可獲取的健保給付大約是 9,000 美元；這些公開實價是益安授權談判與保險給付談判的重要參考指標；保持現金水位是維持談判對等地位、保護股東利益的最核心策略
- 公司近期股價低迷，是否有考慮實施庫藏股以維護股東與市場信心？
 - 進行授權談判時，對手會嚴密審核益安的現金儲備
 - 如果將現金拿去買庫藏股護盤，導致現金吃緊，對手便會採取拖延戰術逼益安因資金壓力接受極不平等的低價授權合約
- Expander-2 臨床試驗目前追蹤至 30 個月（樣本數 N=43），若拉長追蹤至 42 個月，樣本數預估會如何變動？
 - 在長達 3-4 年的長期追蹤中，由於病患症狀已完全解除、生活恢復極高舒適度，往往會失去回診隨訪的動力
 - 甚至曾發生整間合作診所無預警關門、導致 11 位病患一度失聯的案例
 - 因此在樣本數的變動上難以預測
- Urocross 目前在台灣哪些醫院有健保給付，或現階段的自費導入規劃為何？
 - 台灣市場導入初期仍以全自費為主
 - 目前正與台灣各大主要醫院進行臨床導入、進藥與採購談判，優先爭取醫院接受與醫師採用，未來才會逐步考量健保給付的申請
- Duett 主動脈修復醫材，未來的適應症是否僅局限於目前主動脈的三條腦部與上肢血管？
 - 目前產品僅專注於主動脈處供應腦部與上肢的三條重要血管

- 若要擴充適應症，仍需根據不同管徑進行產品與製程優化，並重新進行臨床試驗
- 公司 CDMO 業務在進入 2.0 同時，是否有規劃將法規申報諮詢也納入服務的一環？
 - 多數代工客戶皆有自身長期合作的第三方專業法規代辦公司或內部法規團隊
 - 益安內部的法規與 FDA 溝通能力確實極強，但這是益安為自己新創專案準備的內部核心能力
- CDMO 專案通常前期的研發設計是客戶主動找上門嗎？面對第一階段的高昂成本，公司如何確保費用能被全額 Cover？
 - 目前在美國醫材界已具備高度知名度，現在全部都是客戶主動找上門合作
 - 從前期的工程設計開發，到臨床試驗、設計驗證，最後走到穩定量產，完整週期大約需要 2 年左右
 - 前期的所有研發費用、設計驗證成本，100%由客戶全額 Cover

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬=(十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。